سلام رفیق 「👀🔥」
ایام به کامت 「🐿️🍖」
کانال لوتوس رو دیدی؟ 「😍✨」
*شماره ی اساتید مراکز
*لینک گروه های درسی ترم بهمن
*کتاب‌های آزمون استخدامی
*نمونه سوالات بروز شده و هایلایت
*پی دی اف سرچی و اصلی کتب
*فلش کارت و خلاصه ی درس ها
*تم ایتا،موسیقی،تیکه های کتاب
ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 「🐬😇」
سریع عضو شو از دستش ندی 🚏
بزن رو لینک: 🎓💌

https://t.me/lotus_pnu
https://eitaa.com/lotus_pnu

نکات مهم فصل اول اختلال :

نخستین رفتار مستند نیاز ویژه توسط:ایتارد

اغلب اوقات این رفتار ها حساس تر هستند:نابهنجار

کلمه بهنجار:حد وسط ،معتدل

تفاوت بین هنجار و نابهنجار:از لحاظ درجه رفتار نه نوع رفتار

اختلال رفتاری یک ساختار اجتماعی است.

به معني يک ناتواني که به وسيله واکنش های رفتاری وهيجانی در مدرسه مشخص می‌شود:

اصطلاح اختلال رفتاری یاهیجانی

این اصطلاح شامل یک ناتوانی با دیگر ناتوانی ها همراه است:

اصطلاح اختلال رفتاری یاهیجانی

شامل اختلال محبت اسکیزوفرنی اضطراب:

اصطلاح اختلال رفتاری یاهیجانی

کودکان دارای اختلالات روانی هیجانی هستند اساسا براساس:برونی سازی و درونی سازی شده بررسی می‌شوند.

رایج ترین الگوی رفتاری کودکان دارای اختلالات هیجانی:رفتار ضد اجتماعی یابرونی سازی شده

نابالغ گوشه گیر،منع جدید دررابطه یا رشد با همسالان خود بازی می‌کنند فاقد مهارت دوست یابی هستند و درافسردگی عمیق فرد می روند:درونی سازی شده

رشد و تحول مغز با دستگاه عصبی مختل شده وهم زمان این اختلال بر یادگیری هیجانی و تعاملات اجتماعی ورفتاری فرد تأثیر می گذارد:

عصبی -رشدی

عصبی رشدی شامل ۶ دسته :رشد عقلانی،

اختلال ارتباط ،طیف اوتیسم،بیش فعالی ،نارسایی توجه،اختلال یادگیری وحرکتی

یکی از اختلالات فراگیر رشدی بامنشا نورولوژیک وعلایم روان شناختی :اوتیسم

اوتیسم:تعامل اجتماعی ،ارتباط کلامی و غیر کلامی،رفتار کلیشه ای وتکراری

توانایی دقت کودک و تمرکز بر روی یک موضوع ندارد و کند است فعالیت بدنی غیر معمول بسیار بالا برخورداراست:توجه پیش فعالی

شایع ترین اختلال رفتاری درسنین کودکی و بلوغ است و با افزایش سن ۴۰ درصد از بیماران بهتر میشوند:ADHD

گوشه گیری درسامانه طبقه بندی آماری است جدایی از والدین وافراد که به آن دلبستگی دارند:اضطرابی و هراس های ویژه

به علت جدا شدن از خانه یا افراد وابسته مانند مادربزرگ و ..نگرانی بیش از حد درمورد صدمه ،بی میلی در خوابیدن ،خودداری از رفتن به مدرسه:اختلال اضطراب جدایی

اضطراب جدایی معمولا :در۱۲ الی ۱۸ ماهگی

جدایی برای اولین بار :پیش دبستانی

درحالت عادی قادر به تکلم درموقعیت های خاص دربرابر افراد قادر به حرف زدن نیست به همراه خجالت و اضطراب اجتماعی :لالی انتخابی یاگنگی انتخابی

لالی انتخابی معمولا :قبل از ۵ سالگی شروع تا قبل از ورود به دبستان

ترس غیر منطقی ونامعقول از یک موضوع فوبیا رشته یونانی محرک های فوبی زا ترس بسیار زیادی دارد .

هراس های ویژه در ۱۳ تا ۱۷ ساله ها حدود ۱۶ درصد معمولا از کودکی و نوجوانی شروع و ظرف ۵ سال خود به خود برطرف می‌شود ترس از هواپیما ،مکان های بسته:فوبیای ارتفاع

برونی سازی شده تکراری منفی گرایی لجبازی معمولا ۶ ماه دوام دارد انتقام جویانه بسیار حساس معمولا دربرابر افراد بزرگسال که کودک ک نوجوان با آن آشناست رخ میدهد تعاملات منفی جایگزین میشود:

نافرمانی مقابله ای

شامل ضربه های ناگهانی رفتار خشونت آمیز طغیان کلامی متناوب وتکراری پیامد های مالی و حقوقی سال ها ادامه خواهد داشت شدت آن با افزایش سن کاهش می یابد :اختلال انفجاری

شامل رفتار هایی است که با گذر زمان شکل می‌گیرد وپرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است در میان پسران شایع تر است :اختلال سلوک

ناتوانی از تن دادن به هنجار های اجتماعی جنبه های متعدد درنوجوانی وبزرگسالی تحت ناتوانی درنواحی فقر نشین وغیرثابت این اختلال بیش از ۱۵ سالگی شروع میشود:

اختلال شخصیت ضداجتماعی

بسیاری از کودکان هرچیزی که دم دستشان داخل دهان خود می‌کنند از روی کنجکاوی سیری ناپذیری ومواد غیر غذایی به مدت یک ماه پارچه نخ به همراه اختلال رشدی فراگیر :

هرزه خواری

فرد از افزایش وزن می‌ترسد شایع تر از بی اشتهایی عصبی درزن ها بیشتر از مردها دیده شده است:پر اشتهایی عصبی

سن تقویمی کودکان بهنجار بی اختیاری دفع

حداقل ۴ سال باشد

بی اختیاری دفع: درکودکان بزرگ تر مربوط کودکان ۴ یا ۵ ساله درپسران بیش از دختران سن تقویمی کودک بهنجار بی اختیاری ادرار:۵سالگی

شایع ترین نوع بی اختیاری ادرار:شبانه

بی اختیاری ادرار در دختران بیش از پسران پس از ۹ سالگی بسیار نادر است

انجام مطلوبیت یک فعالیت مشخص دریک زمان ومکان اجرای تست میسنجد:

تست هوش بهر

توانایی توسعه وحفظ روابط بین فردی درکودکی ونوجوانی : یکی از عامل های سازگاری درآینده است.

نکات مهم فصل دوم :

پاسخ های رفتاری هیجانی که درمدرسه بهنجار های سنی فرهنگی تناقض داشته وبرعملکرد تحصیلی اجتماعی تأثیر منفی بگذارد:

اختلال رفتاری

حداقل ۲۲ درصد کودکان و نوجوانان درسنین مدرسه مشکلات جدی و مستمر رفتاری دارند.

دوران کودکی درقالب مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده از گسترده ترین وپرکاربردترین طبقه بندی اختلال دوران کودکی است (به وسیله اخنباخ و رسکورلا)

درونی سازی شده:به شکل کناره گیری ،گوشه گیری ،بیش از اینکه طرف آزار ببینید خود کودک آزار می‌بینید.هسته اصلی خلق یا هیجان از سال دوم افزایش می یابد میزان نگران کننده درسال های پیش از نوجوانی مشکلات درونی سازی شده کاهش می یابد و درسال های نوجوانی افزایش می یابد.

روان پریشی:شدت کمتری دارند وکودک کمتر درمانده وناتوان می سازد با اضطراب همراه نگران و ترس شدید و با رفتار های تخریبی اختلال مربوط ب خواب وناراحتی جسمی معده درد همراه است.

برونی سازی شده:الگو سازش نیافته در تعارض با یکدیگر افراد وانتظاراتشان قرار میگیرد. پرخاشگری،پیش فعالی ،تکانشگری

اخلال گرانه می نامند در ۵ راهنمای تشخیصی قرار دارد.

الگوی کرداری :تکراری و پیوسته تجاوز به حقوق اولیه دیگران متناسب با سن است.

شیوع این مشکلات بین ۷ تا ۲۶درصد تخمین زده شده است.

جایگاه کودک از نظر تربیت تولد یا تک فرزند درشکل گیری شخصیت از بدو روان شناسی مدرن مورد توجه بوده است.

ادلر:با وجود خواهر و برادر با والدین یکسان و در یک خانه زندگی میکنند محیط اجتماعی یکسانی ندارند ودر معرض باز خورد های مختلف والدین و شرایط کودکی مختلف به وجود می آورد.

بامیستر:تولد کودک جدید با افزایش مشکلات سازش ورفتاری در فرزندان بزرگ تر مانند پرخاشگری ارتباط دارد.

ساطوریان و همکاران :فاصله سنی و تربیت تولد فرزندان تأثیر معناداری ب مشکلات برونی سازی شده کودکان دارد.و تفاوت سنی کمتر از ۲ سال بیشترین میزان مشکلات برونی سازی شده رانشان دادند.

پاترسون:اختلالات برونی سازی شده نتیجه شکست دراعمال قوانین والدینی که معمولا دارای سه ویژگی بی ثبات ،نظارت کم،مهارت ضعیف واین نوع فرزند پروری کودک را به سمت نا فرمانی سوق میدهد.

کرافورد:دررابطه غیر مستقیم میان تنظیم هیجان واختلال های درونی سازی شده عاطفه منفی مادر نقش واسطه ای دارد.

ویژگی افراد نورزگرا:تردید در تصمیم گیری واعتماد به نفس پایین که بر کارایی روش فرزند پروری اثر می گذارد.

فرزند پروری ناکارآمد:مهم ترین پیش بینی کننده اختلال های برونی سازی در فرزندان.

شخصیت منفی مادر دررابطه بین خلق نوباوه واحتیاط اجتماعی در۷ سالگی نقش واسطه ای داشته ونمرات پایین مادر دربعد وظیفه شناسی ۵ ابعاد شخصیتی درپسران است.

دلبستگی بر مادران وکودکان خردسال وتوجه اندکی به نقش پدر شده است.

دل بستگی اولیه کودک با مادر شکل میگیرد.

رایس به نقل ویلمایز:رابطه دل بستگی سالم میان پدر و کودک دربرابر مشکلات رفتار درونی و برونی سازی شده محافظت میکند.

مکانیسم اول:فرایند نظم جویی هیجانی ارتباط با دل بستگی راهبردهای مقابله با تنیدگی

مکانیسم دوم:رفتار قابل مشاهده است از هم گسیخته

مکانیسم سوم:شناخت اجتماعی مدل های کاری مینامند.

مکانیسم چهارم:کنش وری انگیزشی درمبادلات اجتماعی افزایش مثبت وبادوام روابط گرم و صمیمی

ویژگی سرشت و منش:نسبت پایدار واکنش پذیری تنظیم هیجانی با وراثت پاسخ های بدنی و غیر ارادی

ایگم:کودکانی که در ۶ سالگی به لحاظ سرشتی شرم زیادی داشتند در۴ سال بعدی مشکلات درونی سازی نشان میدهند.

بیماری ارثی فشار روانی:ارتباط فعالی بین آمادگی های ژنتیکی زیست شناختی و فشار زایی محیطی ارائه میکند. از دست دادن معشوق،تصادف های جسمانی.

رایج ترین روش های مداخله روی والدین آموزش رفتاری والدین bptاست.

یکی از روش های متمرکز برکودکان و نوجوانان درمان شناختی رفتاری است.

ساپ و فارل:عواطف را نمیتوان به صورت مجزا رسیدگی کرد فرایند هم پوش هستند.

مهارت اجتماعی: ترکیبی از مهارت های حل مسئله کنترل خشم وابزار وجود است.

بازی درمانی یک روش درمانی مناسب برای کودکان ۳تا ۹ ساله است.

شرط اساسی پذیرفته شدن درگروه درمانی:عطش اجتماعی نیاز به پذیرش ومیل به کسب پایگاه وحفظ حرمت در گروه است.

بهترین شیوه مهار پرخاشگری کاهش خشونت درکودکان پرورش ارتباط همدلانه بدون خشونت ومحبت آمیز است.

ارتباط همدلانه و غیر خشونت امیز:یکی از توانایی هیجانی نشانه و نمودهای اوایل کودکی آغاز می‌شود.

نکات مهم فصل سوم درس اختلال رفتاری هیجانی :

پیش فعالی شاید رایج ترین همگاني ترین واژه به کار گرفته برای نوعی اختلال روان شناختی دردوران کودکی است.

اختلال نارسایی:ضعف در بازداری رفتاری دارای سه خصصیه درجاتی از کم توجهی تکانش گری پیش فعالی و پیدایش قبل از ۷ سالگی.

ویژگی اصلی اختلال رفتاری از لحاظ اجتماعی وباید قبل از ۱۲ سالگی در دو محیط مستقل اتفاق بی افتد.

درکودکان ۹ تا ۱۷ پورتوریکو تاکید شده

Adhd:شایع ترین اختلال روانی است.

علام چهره ای ظاهری ندارندنابهنجار های خفیف فاصله زیاد بین دوچشم کم ناکامی،خیلی از والدین هنگامی که کودکان نوپا اولین فعالیت حرکتی مفرط مشاهده می‌کند رفتار های هیجانی بسیار قبل از ۴ سالگی دشوار است.

درپسر ها شایع تر است.کودکان تقریبا ۲ به ۱ دربزرگسالان ۶ به ۱ است

ایالت متحده برای جمعیت امریکایی لاتینی پایین تر از جمعیت های سفید پوست هستند.

بهبودی در صورت وقوع معمولا بین ۱۲ تا ۲۰ سالگی قبل از ۱۲ سالگی نادر است.

تکانش گری کودک در بدو ورود به مدرسه به صورت پاسخ سریع و غلط به مسائل ریاضی آشکار می‌شود.

جزئیات رفتار کودک که ممکن است از طریق مقیاس های درجه بندی نادیده گرفته شوندمیتوان از مصاحبه به دست آورد.

مشاهده کودک می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی اختلال فراهم آورد.تکلیف کودک پیدا کردن یکی از شش عکسی است که با شکل استاندارد جورباشد.

عملکرد تکلیف جور کردن براساس نمونه برای شناسایی کودکان پیش فعال مفید است.

تصادفات وتخلفات در رانندگان مبتلا به adhdشایع ترند. احتمال وجود چاقی زیاد است.

سبب شناسی ودرمان:علت واحدی وجود ندارد پیش زمینه ژنتیکی مواد سمی در آن دخیل اند.

ژنتیکی و فیزیولوژیکی:درخویشاوندان تنی درجه یک مبتلا به adhdبیشتر است.با ژن های خاص همبستگی دارند اختلالات بینایی شنوایی کمبود های غذایی،

محیطی: وزن کم به هنگام تولد خطر دویا سه برابر دچار adhdشامل نمی‌شوند این ارتباط بیانگر خط ژنتیکی متداول است.

خلق و خوی:کاهش بازداری کنترل پرزحمت

عده ای بخش های خاص از مغز پیشانی لیمبیک را دخیل هستند نارسایی عصب شناختی می نامند.

مصرف زیاد مواد قندی کاملا غیر واقعی قلمداد می‌شود.

عوامل ژنتیک:در دو قلوه های یک تخمکی نسبت به دو تخمکی خطر ابتلا درخواهران ک برادران پیش فعال نسبت به کودکان بیشتر است.

آسیب مغزی:اگر در دوره جنین یا شیر خوارگی به آسیب مغزی برسد می‌تواند در شکل گیری موثر باشد و با دستگاه انسفالوگرام صدمات مغزی و شناسایی کرد.

عصبی شیمایی :ناقل های عصبی مغزی نشانه پیش فعالی

خلق و خو:میدان توجه نامحدود به دلیل محرومیت هیجانی کودکان پرورشگاهی

رژیم غذایی:چاشنی و رنگ مصنوعی تشدید علائم پیش فعالی نقش دارند.

آلرژی و اسم:داروهای محرک موثر ترین روش درمانی برای کمک کودکان مبتلا به adhdاست.

دارو محرک:فندیت،دکستروامفتامین،پمولین کنترل کودک بر رفتارش را افزایش می‌دهد.

رفتار غیر قابل کنترل کودک را وادار می‌کند که تسلیم شود.

کلونیدین وگوان فاسین :برای کودکان که تیک دارند و با کودکان پرخاشگر به سختی می‌خوابند توصیه می‌شود.

مهم ترین داروهای مورد استفاده برای درمان adhdشامل:فندیت دکستروافتامین وپمولین می باشد.

داروهای ضد تشنج:دپاکوت،تگرتول،کارباترول،کلونوپین موقعی استفاده میشود که داروهای دیگر جواب نمی‌دهد.

درمان های خاص :ترک کردن صندلی،صحبت کردن به طور مناسب تاکید می‌شود می‌توان توالی را درپیشایند ها ،رفتار و پیامد ها خلاصه کرد.

افکار غیر منطقی وتحریف شده می‌تواند موجب بدرفتاری فردشوند.

پیش فعالی جنسیت:رفتار های مخاطره آمیز در مردان دیده می‌شود ملایمت مشکلات ویژگی های که در فرزند پروری اختلال ایجاد می‌شود مایه نگرانی زیاد است.

مادران طبقه اجتماعی پایین تر احتمالا طی دوران حاملگی تغذیه کمتر مشکلات بارداری در آن ها زیاد است.

محیط اشفته:دارای وضعیت پایین می‌تواند بالاتر بودن بی ثبات والدین توجیه کند.

ورفتارکم توجهی را داشته باشد.

🔰نکات فصل چهارم:

اختلال اضطرابی شایع ترین اختلالات روان پزشکی جامعه است.شامل :ترس وناراحتی زیاد پیش بینی کننده وقوع یک تهدید درآینده هستند.

مولفه شناختی ترس انتظار خطري واضح وخطری مهم است.

سیستم ترس درخدمت پاسخ جنگ یا گریز است وبرای حفاظت از انسان طراحی شده

شایع ترین پی آمد اضطراب اجتناب از موقعیت یا شی ترسانده است.باعث لکنت زبان بی خوابی پرتحرکی شایع ترین اختلال رفتاری ناشی از اضطراب اجتناب یا گریز است.

اختلال اضطرابی به طور شایع در خانواده ها وجود داردپزشکان: که کودکان مضطرب والدین مضطرب دارند.

سن اضطراب فراگیر ۱۰ تا ۱۴ سالگی است.

ویژگی تشخیصی:فرد به طور دائم نگران رویداد های آینده است و از آن می‌ترسد و نگرانی مزمن وبیمار گون منجر می‌شود.نگرانی یک فرایند شناختی فرد مبتلا به اضطراب راهبردی برای کشف کنار آمدن با خطرات تهدید کننده تبدیل می‌شود.

معمولا با اختلال وحشت زدگی فوبی اجتماعی فوبی خاص افسردگی اساس ptsdرخ می دهد.

همبودی با اختلال:درنهایت به اختلال وحشت زدگی پانیک دچار میشود احتمالا به اختلال افسردگی مبتلا می‌شود.

اضطراب فراگیر همراه :افسرد خویی،اختلالات مرتبط با مواد

سبب شناسی ودرمان:سوگیری پردازش سرکوب شدید هیجان عدم کنترل برورویداد های زندگی

اختلال اضطراب فراگیر ۱۵ تا ۲۰ درصد ژنتیکی وهورمون کورتیکوتروین و بی نظمی فراگیر است.

درمان دارویی :داروهای مهار کننده باز جذب سروتونین هستند.

رایج ترین درمان اختلال اضطراب فراگیر درمان شناختی رفتاری است.

مدل شناختی دوگاس،گاگنون،لاداسر،

فریستون تحت عنوان درمان عدم تحمل بلاتکلیفی است.

درمان عدم بلاتکلیفی توسط دوگاس و همکاران چهاربخش :افزایش تحمل بلاتکلیفی،ارزیابی مجدد، اصلاح جهت گیری ،کاهش اجتناب شناختی.

فوبی های خاص:ترس های افراطی ،غیر منطقی ومدوام نسبت به یک شی تا ۱۰ سالگی دردسری را ایجاد نمی‌کند.سنین قبل از مدرسه رایج است.

ویژگی تشخیصی:حضور در یک موقعیت خاص

وجود ترس مداوم و شدید سن شروع بستگی به نوع فوبی کودکی نوجوانی و بزرگسالی دارد.

تفاوت جنسیتی:فوبیای خاص یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی در زنان است.

فوبی خون و جراحت

فروید:دفاع علیه اضطراب تکانه های سرکوب شده نهاد است.

ژنتیکی و خلق و خوی:کودکان ۲۱ ماه کم رو نبودند درمعرض خطر ابتلا در ۷ الی ۸ سالگی کمرو نبودند درمعرض فوبی قرار می‌گیرند.

هراس اجتماعی:زمانی مشخص می‌شود که فرد به هنگام انجام کار درمقابل دیگران دچار احساس ناراحتی و ترس شدید دارد.

اضطراب اجتماعی:نوعی نگرانی شدید مزمن و پایدار فرداز قضاوت دیگران در مورد ظاهرش یا رفتارش یا خجالت کشیدن وتحقیر شدن درحضور دیگران دارد.غلبه کردن بر این ترس برایش سخت است.شامل سرخ شدن،تعریق زیاد،حملات پانیک نیز ممکن است اتفاق بیفتد تشخیص و دخالت زود هنگام به حداقل شدن علائم کند شدن پیشرفت آن کمک کند.

ترس ممکن است ۶ ماه یا بیشتر طول بکشد.

دوقطبی و اختلال بد شکلی بدن هم زمان است درکودکان هم زمان اختلالات با اوتیسم وسکوت انتخابی شایع است.

مونوامین اکسیداز :داروی ضد افسردگی

اختلال پانیک یا اختلال وحشت زدگی:با حملات مکرر وغیر قابل انتظار به حمله پانیک معروف است.تجربه ای از دوره ترس ۴ علامت تجربه می‌کند.خود به خود و بدون محرک و به مدت ۱۰ دقیقه شدت علائم به اوج می رسد.حملات وحشت زدگی شدید است و سریعا افزایش یافته و ممکن چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد وکمتر از ۳۰ دقیقه :

تپش قلب،تعریق،لرزش،درد سینه،ترس از مرگ

از نظر هیجانی:دربیم شدید یا دگرسان بینی خود می‌شود.

از نظر جسمانی:شامل واکنش اضطراری

شناختی:فکر می‌کند دچار حمله قلبی شده یا دیوانه می‌شود.

رفتاری:به پزشک مراجعه می‌کند و دارو مصرف می‌کند.

در سال های بین ۲۰ الی ۲۴ شایع است.

یک عامل بسیار مهم دراختیار پانیک تجربه عوامل استرس برانگیز بیش از شروع علائم است.

داروی ضد افسردگی:فلوکستین وسرترالین

ضد اضطرابی:زاناکس،کلونازپام

لالی انتخابی:در حالت عادی قادر به تکلم در برخی موقعیت های خاص حرف نمی‌زند.

امتناع دائم از صحبت کردن تقریبا درتمام موقعیت های اجتماعی فهم سخنان دیگران وتوانایی سخن گفتن است.

قبل از ۵ سالگی همراه با یک ضربه جسمی ک روانی تا زمان ورود به مدرسه افزایش تعامل اجتماعی وتکلیف عملکردی دارد.

در دختران کم تر از پسران است.

علت لالی انتخابی یک مهار روان شناختی سابقه شروع دیر رسی تکلم دیده می‌شود.

یکی دیگر از عوامل اختلال مشکلات درتلفظ یا لکنت زبان است.

اگورافوبیا: زیر مجموعه اختلال که به هراس و ترس حضور در مکان های باز وشلوغ دارند.

ترس از ترک کردن خانه خود وحشت دارند افزایش در فاصله مکانی اضطراب آنها نسبت تقریبا مستقیم دارند هرچه فاصله بیشتر باشد ترس بیشتر است. همیشه می‌ترسند.

دوران بلوغ دراواخر جوانی در کودکی بسیار نادر است.گذر هراسی ۱۷ سالگی است.

اختلال افسردگی و اختلال مصرف الکل است.

ادامه نکات فصل چهارم :

حسایت زدایی نظام دار:روش حساب شده و ایمن درمعرض موضوع یا موقعیت هراس قرار می‌دهند متداول ترین ابتدا در ذهن وبا کمک قوه تخیل سپس در واقعیت.

درمعرض مورد هراس آور قرار گرفتن احساس کنترل بر آن ترس در فرد بیشتر می‌شود و این احساس کنترل کردن موقعیت مهم ترین دستاورد این شیوه است.

مواجه درون تنی:مواجه عمدی با احساس های درونی ترسناک است ترس از موقعیت های اگورافوبیک درمان شود یعنی از طریق مواجه طولانی با احساس های درونی تا اینکه ترس خاموش شود.

نکات فصل پنجم:

بارز ترین رفتار های مقابله ای بین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی ودر سه سالگی به اوج می رسد.

زمانی که رفتار ها به طور مکرر تکرار شود حالت شدیدی به خود بگیرد اختلال نافرمانی مقابله ای تبدیل می‌شود.

یکی از علت های مهم و رایج مراجعه به کلینیک های سلامت روان است.

اختلال نافرمانی مقابله ای خفیف ترین اختلال در نظر گرفته می‌شود.

نخستین نشانه های شبیه اختلال نافرمانی مقابله ای می تواند خلق و خوی دشوار وتحریک پذیر بالا در کودکان باشد.

زود رنج،حساس بودن پرخاشگری به مدت ۶ ماه تدوام دارد.

اختلال نافرمانی مقابله ای ممکن از ۳ سالگی شروع شود.

سن شروع از ۸ سالگی ومعمولا بیش از ۸ سالگی پیش از جوانی تشخیص می‌دهند.

متیل فندیت اتوموکستین افتامین دکستروافتامین :درمان اختلال نافرمانی مقابله ای موثر

برنامه های آموزش مدیریت رفتار به والدین رایج ترین وموثر ترین رویکرد دردمان کودکان خردسال مبتلا به رفتار ایذایی است.رفتار کودک مبتنی برتعاملات وی با افراد مهم زندگی والدین می باشد.

برنامه آموزش موفق :تکنیک افزایش رفتار مثبت وکاهش رفتار منفی ،کمک با والدین دردرک دیدگاه اجتماعی ،مشارکت هردو والد در برنامه،یادگیری مداخله یادوره پیگیری بلند مدت

نکات فصل ششم درس اختلال رفتاری هیجانی:

مشکلات سلوک نامتناسب با سن گفته میشود به نقص انتظارات خانوادگی حقوق شخصی دیگران می انجامد.

یکی از دشوارترین کارها برای معلمان اداره کردن دانش آموزان که همیشه نارام هستند ورفتار ضد اجتماعی دارند.

اختلال سلوک:رفتار های پایدار با گذشت زمان شکل می‌گیرد و پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است.الگوی تکراری هنجار اجتماعی متناسب با سن وقوانین را زیر پا میگذراد.

عدم سازگاری اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل درگیر با این کودکان مطرح است.

رفتار های سلوک حداقل باید ۱۲ ماه وجود داشته باشد.

بیشترین شیوع اختلال سلوک دردوره کودکی ک نوجوانی است.

پسرا اکثرا درفاصله سنی ۱۰ تا ۱۲ ودختران ۱۴تا ۱۶سال مشمول ملاک می‌شوند.

Dsm:تمایز مهمی بین نوع اختلال سلوک با شروع در کودکی نوجوانی قائل شده است.

سه نوع فرعی دارد:دوره کودکی،نوجوانی، نامتمایز ک حداقل یکی از این موارد قبل از ۱۰ سالگی شروع میشود.

نمره پایین گمارش کلاس های آموزش ویژه افت تحصیلی دلایل رایج مشکلات به مدرسه ویادگیری است.

کودکان مبتلا به اختلال سلوک درارتباط شان با همسالان پرخاشگری بدنی و کلامی مهارت اجتماعی ضعیفی نشان می‌دهند.

طرد اجتماعی توسط همسالان عامل مخاطره آمیز نیرومندی برای بروز مشکلات سلوک در نوجوانی است.

مشکلات خانوادگی جدی ترین و باثبات ترین همبسته های اختلال سلوک است.

آشفتگی عمومی:مربوط به سلامت روان مادر ارزش ضد اجتماعی خانواده

آشفتگی ویژه:فرزند پروری سخت گیرانه،نبود سرپرست

مزاج:خلق نوزاد ومیانگین هوش پایین تر

محیط:تغییرات زیاد مراقبان ،خانواده پرجمعیت ،والدین مجرم

اجتماعی:همسالان بزهکار،مواجه با خشونت همسایگان

افرادی که مبتلا به سلوک شده اند معمولا ۱۸ سال دارند کسانی که بد از ۱۸ سالگی دچار می‌شوند اختلال شخصیت ضد اجتماعی را ندارند.

خانواده را باید اولین زمینه برای روند اجتماعی شدن کودکان به حساب آورد خانواده عامل مهمی درایجاد اختلال سلوک است.

چهار الگوی اختلال سلوک:انحراف رفتاری،طرد فرزندان،فقدان انضباط،تعارض زناشویی

شیوه فرزند پروری :دراختلالات رفتاری نقش دارند والدین به کودکان معمولا به شیوه زورگویانه ومنفی پاسخ می‌دهد.

یک شکل جدی از منفی گرایی والدین آزار جسمی است.

جوریلس نقل از همکاران متیس و لاکمن:ارتباط چاقو واسلحه کشی وخشونت های بین والدین با اختلالات رفتاری کودکان را بررسی کردند.

پترسون:والدین کودکان رفتار مثبت و منفی رابه صورت ناهماهنگ پاداش می دادند.

فقدان انضباط با سرپرستی فرزندان:

کودک استفاده از رفتار زورگویانه درپی تقویت می‌شود همراه با گذشت زمان کودک بیشتر زور بگوید رفتارش احتمالا تا حد کتک زدن وتعرض کلامی شدت می یابد.

طلاق تنها عامل موثر دراین اختلال نیست بلکه شواهدی والدین و خانواده درپیدایش اختلال سلوک است.

درمان:هیچ راه درمانی برای تمام طیف های رفتاری های اختلال سلوک درمان بخش شمرده نمیشود برای کاهش درمان اختلال نافرمانی مقابله ای، مدیریت والدین،خانواده درمانی، درمان شناختی رفتاری است.

آموزش مدیریت رفتار کودک: دراین روش درآن تکنیک های یادگیری اجتماعی برای تغییر رفتار به والدین آموزش داده میشود.به صورت فعالانه آموزش داده میشود شیوه عملی بیاموزند.

تفکر ناکارآمد وتحریف شده با اختلال سلوک همراه است.

آموزش مهارت های اجتماعی درپیشگیری از اختلال سلوک نقش موثر دارد.

نکات مهم اختلال های رفتاری هیجانی

🔰(فصل هفتم)

📙رژیم غذایی طولانی مدت بستگی‌داردبه:

┣عامل جنسیت

┗عامل رشدی

🍊پیکا یا هرزه خواری

┣خوردن مواد غیر غذایی

┣حداقل مدت ۱ ماه

┗حداقل سن برای تشخیص ۲ سال

🦊شدت بستگی دارد به:

┣درجه محدودیت محیطی

┗عقب ماندگی

🍊اختلال نشخوار

┣بازگرداندن غذای خورده شده به دهان

┣به صورت منظم تکرار به صورت ۱ ماه

┣حرکات غیر ارادی دارند

┣درنوزادانوکودکانکوچکتر«شایعدرپسران»

درمان☜روش رفتار درمانی

🥃اختلال اجتناب محدودیت غذا

┣محدودیت غذا

┣محدودیااجتنابکردنازخوردنغذا

┗یک رفتار عمد از سوی کودک برای کنترل والدین☜مرتبط با استرس و افسردگی و اضطراب

🔥بی اشتهایی عصبی(الفورکسیانورزا)

┣شایعدرطبقهثروتمند☜درمان:حذفـوالدین

┣ترس‌ازچاقی☜درنوجوانان‌دختر۶تا۱۳سالگی ☜منجربه‌سوتغذیه

پراشتهایی عصبی(بولیمیا)

به‌طورمرتب‌پرخوری‌می‌کند☜بلافاصله‌باروزه‌داری‌یاداروی‌جبران‌ولین‌می‌کند

بلافاصله‌باروزه‌داری‌یاداروی‌جبران‌ولین‌می‌کند

یک بار در هفته به مدت ۳ ماه

نکات فصل هفتم درس اختلال رفتاری هیجانی:

عادت غذا مشکل آفرین وتمایل به چند غذایی از ویژگی بارز دوران کودکی است.

از ۹ سالگی دخترا درباره کم کردن وزن مضطرب از پسرا هستند.

تمایل به لاغری یک متغیر انگیزش کلیدی است آن فرد فکر می‌کند کم‌کردن بیشتر وزن پاسخی بر غلبه به مشکلات ورسیدن به موفقیت است.

درمیان کودکان ۷ الی ۱۰ ساله نگرانی درباره وزن رژیم غذایی وظاهر شایع است.

انتقال ب نوجوانی:کمترین تغییرات درشکل بدنی نیازمندی سازگاری درخودانگاره مروبط به نگرانی به تغذیه وزن دراوایل نوجوانی مشکلات جدی فراهم کنند.به طور متوسط ۱۱ کیلو بدن آن افزوده شدن نوجوانان آمریکا شمالی درسنین پایین رژیم غذایی می‌گیرند رژیم غذایی طولانی مدت وعوامل رشدی وابسته است.

گرسنگی:انگیزه فیزیولوژیکی جوانب معتدد اجتماعی و روانی خاص روی افراد تأثیر می گذارد.

اسکالونا:کودکان سنین ۱۰ روزه تا ۲۴ ماه تحت مشاهده قرار میدهد.اصولی ترین دلیل امتناع از خوردن محیط ایمن عاطفی درهنگام خوردن بود.

اصطلاح پیکا:از قرن دوم شناخته شده است.

به عنوان فساد تباهی اشتها،ورحم

هرزه خواری :غیر غذایی به صورت مداوم طی یک ماه است.

حداقل سن ۲ سالگی برای تشخیص هرزه خواری توصیه می‌شود.

شیوع هرزه خواری نامعلوم است.

عوامل فرهنگی:خانواده ،مذهب

نشخوار:غذای خورده شده رابه دهان باز

می گرداند ودوباره آن را می جود. حرکات غیر ارادی داشته باشد.نشخوار دراختلال باید مکرر باشدحداقل چند بار در هفته روی دهد به خصوص به صورت روزانه. بین ۳ تا ۱۲ ماهگی

ودر نوجوانان و بزرگسال کمتر دیده می‌شود.

سروولیام ویتی گال:نخستین بار اختلال بی اشتهایی عصبی به عنوان یک بیماری خاص معرفی کرد.

چارلز لازگ:بی اشتهایی عصبی دیدگاه اجتماعی روانی توصیف کرد. و به این دو به این نتیجه رسیدند که ثروتمند ترین اختلالات است.

بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی با رژیم گرفتن به سوتغدیه خطرناک تر می‌شوند.

پر اشتهایی عصبی :از ۹ سالگی درباره وزن و تناسب دختران بیش از مضطرب هستند.

افراد دارای اختلالات خوردن در فعالیت عصب شیمیایی مغز اختلالاتی دارند.

افراد دارای پر اشتهایی عصبی برای بهبود انگیزه بی اشتهایی عصبی دربرابر درمان مقاوت می‌کنند.

درمان میان فردی: بر منابع میان فردی استرس دراین اختلال متمرکز است موثر است.

🔰نکات فصل هشتم درس اختلال رفتاری هیجانی:

رفتار سازی:درعین حال ساده میزان انطباق فرد توقعات محیط وجامعه اشاره دارد.مجموعه رفتار های که افراد خود کفا و لایق شایستگی عملکرد های فردی درامور روزانه

هیوارد:رفتار سازی برحسب سن فرد انتظارات فرهنگی سنی خود برساند.

رفتار اجتماعی:شامل مهارت کمک کردن ،تشکر،عذرخواهی برای انجام کار مهارت ارتباطی وتعامل با همسالان ودیگران می باشد.

دیانا باو مریند:۳ ویژگی آشکار می سازد:سهل گرایانه،مستبندانه،مقتدرانه

سخت گرایانه:محدود کننده،متوقع و صریح است.کنترل شدید و تبادل کلامی ناچیزی دارند. گاهی به جای فرزند تصمیم می‌گیرند و بی چون و چرا باید قبول کند.

والدین مستبد کنترل مستقیم ناموجه به نوع ظریف تری به نام کنترل روان شناختی می پردازد.

مقتدرانه:به استقلال تشویق می‌کنند برای آن محدودیت قائل می‌شوند عملکرد آن را کنترل می‌کنند.

روش فرزند پروری مقتدرانه موفق ترین روش فرزند پروری پرورش وروابط نزدیک بالا روش های کنترل سازگارنه واستقلال دادن مناسب را شامل می‌شود.

اغماض گرانه:هیجانی جدا و افسرده هستند غرق در استرس خانوادگی وقت و انرژی کمتر غیر پاسخگو و پرتوقع معمولا طغیان گر لوس از لحاظ اجتماعی نالایق هستند.اغماض گرانه در حالت افراطی نوعی بدرفتاری کودک که غفلت مینامند.

سهل گیرانه:درزندگی فرزندان خود دخالت نمیکنند ممنوعیت و محدودیت اندکی قائل می‌شوند بیش از حد پاسخگو هستند غیر سنتی واسان گیر هستند نیازی به رفتار نابالغ ندارند.

عوامل خطر ساز اختلال سلوک :تعارض بین والدین

تعاملات والد و کودک مکانیسمی و از رفتار های ضد اجتماعی یاد می‌گیرد.

ویز و همکاران:میزان سخت گیری و خشونت دراصول تربیتی والدین با ارزیابی معلمان و پرخاشگری کودکان رابطه مستقیم دارد.

برک:سوتغییر وتحریف نشانه از سوی کودک تعامل با همسالان علل اختلال نافرمانی مقابله ای می دانند.

والدینی که برپرخاشگری فیزیکی برای به دست گرفتن کنترل کودکان متکی هستند احتمالا کودکانی خواهند داشت که دارای رفتار های پرخاشگرانه تری هستند.